

Benevita, perguntas e respostas

Um roteiro para você apresentar o Benevita com segurança. As perguntas estão agrupadas por tema, e as respostas são fiéis ao que o aplicativo faz hoje, incluindo os limites conhecidos e o caminho de evolução de cada um. Responder com honestidade sobre limites transmite mais confiança do que fingir que não existem.

1. Produto e funcionalidades

P: O que é o Benevita, em uma frase?

R: É um aplicativo de gestão e acompanhamento de cuidado domiciliar: o enfermeiro registra o plantão pelo celular, a família acompanha em tempo real e a empresa administra pacientes, equipe, escalas e financeiro em um só lugar.

P: Que problema ele resolve?

R: Hoje o registro do cuidado domiciliar vive espalhado em papel e WhatsApp, sem histórico confiável nem transparência para a família. O Benevita centraliza tudo, com trilha do que foi feito e quando, e aproxima a família do cuidado.

P: Quem usa o aplicativo?

R: Três perfis. A empresa (admin) administra pacientes, equipe, escalas e financeiro. O enfermeiro registra o plantão, com funcionamento offline. A família acompanha o cuidado do paciente em tempo real.

P: O que é o modo família e como difere do modo empresa?

R: No modo empresa, uma clínica é a cliente e administra tudo. No modo família, a própria família se cadastra sozinha, cadastra quem recebe o cuidado e convida o enfermeiro que já atende, sem precisar de uma empresa por trás. É o mesmo aplicativo, com a família no comando do próprio ambiente.

P: Funciona sem internet?

R: Sim. O enfermeiro registra o plantão mesmo offline, e os dados sincronizam quando a conexão volta. Isso é essencial no atendimento domiciliar, onde a conexão nem sempre é boa.

P: Tem versão para iPhone e Android?

R: Sim, é um aplicativo único que roda nos dois sistemas.

2. Tecnologia e arquitetura

P: Qual é a stack?

R: React Native com Expo (SDK 54) no aplicativo, TypeScript em modo estrito, e Firebase (Autenticação e banco Firestore) no backend. Navegação com React Navigation, estado com Zustand, formulários com validação. É uma base moderna e amplamente adotada.

P: Por que Firebase e não um servidor próprio?

R: O Firebase entrega autenticação, banco em tempo real, escala automática e regras de segurança no servidor sem manter infraestrutura. Para um produto neste estágio, isso reduz custo e tempo, e as regras do Firestore aplicam a segurança no servidor, não só na tela.

P: Como os dados são organizados?

R: Arquitetura multi-tenant: cada empresa (ou família, no modo familiar) é um espaço isolado, e todos os dados vivem dentro dele. Uma empresa nunca enxerga os dados de outra, isso é garantido pelas regras do servidor.

P: É nativo ou híbrido?

R: É React Native, que gera aplicativo nativo de verdade para iOS e Android a partir de uma base de código só. Não é um site embrulhado: usa componentes nativos, câmera, localização e armazenamento offline.

P: Onde ficam as fotos clínicas hoje?

R: Hoje as fotos são guardadas dentro do banco, em formato de texto. Funciona para o volume atual, mas o próximo passo natural é mover para o armazenamento de arquivos dedicado (Firebase Storage), que já está previsto. É um limite conhecido, não um esquecimento.

Dica: Se perguntarem, seja direto: funciona hoje, e a migração para Storage é o próximo passo quando o volume de fotos crescer.

P: Tem testes automatizados?

R: A qualidade hoje é garantida por checagem de tipos (TypeScript estrito) e análise de código (linter) a cada mudança, obrigatórios antes de concluir qualquer tarefa. Testes de unidade e integração são o próximo degrau de maturidade, ainda não implantados.

3. Segurança de dados e LGPD

P: Como os dados de saúde são protegidos?

R: Em várias camadas: acesso por autenticação, permissões por papel, isolamento entre empresas, e regras no servidor que decidem quem pode ler e escrever cada dado. A tela nunca é a única barreira, a regra do servidor é.

P: O que impede um enfermeiro de ver pacientes que não são dele?

R: Cada paciente tem uma lista de enfermeiros autorizados, e a regra do servidor exige que o enfermeiro esteja nessa lista para ler o paciente e o prontuário. Quem mantém a lista é quem tem autoridade: a empresa (pela escala) ou a família (no modo familiar). Sem autorização, o enfermeiro simplesmente não enxerga.

P: Quem é o controlador e quem é o operador na LGPD?

R: No modo empresa, a empresa cliente é a controladora dos dados (ela decide e responde), e o Benevita atua como operador, tratando os dados conforme instruções. Essa divisão está prevista no contrato de prestação de serviço.

P: Como funciona o consentimento?

R: No primeiro acesso, o usuário lê e aceita os termos de uso e privacidade, e esse aceite fica registrado com data e versão. A base legal para o tratamento é a tutela da saúde, prevista na LGPD.

P: Por quanto tempo os dados são guardados?

R: Os dados que compõem o prontuário são retidos por no mínimo 20 anos, contados do último registro, conforme a Lei 13.787/2018. Essa obrigação de guarda é da controladora, a empresa.

P: Vocês verificam se o enfermeiro é realmente registrado?

R: O registro profissional (COREN) é estruturado e guarda o atesto de quem conferiu, com autor e data. O Cofen não tem uma consulta automática pública, então a conferência é assistida: o app abre a consulta oficial e o administrador confirma. O que isso entrega é a trilha de responsabilidade. A verificação automática por serviço pago é uma evolução futura.

Dica: Assuma que hoje é conferência humana com trilha, não validação automática. É honesto e defensável.

P: Existe trilha de auditoria?

R: Sim. Eventos importantes (login, aceite de LGPD, criação de registro, checkin e checkout de plantão) ficam gravados de forma imutável, com quem fez e quando. O próximo passo é mover essa gravação para o servidor, o que a deixa à prova de adulteração total.

P: E se a conta de um enfermeiro vazar ou ele for desligado?

R: O administrador desativa a conta, o que corta o acesso ao aplicativo e revoga o acesso aos pacientes na mesma ação. A conta pode ser reativada depois, mas o acesso aos pacientes precisa ser concedido de novo, de forma explícita.

P: Os dados são criptografados e onde ficam hospedados?

R: Sim, criptografados em trânsito e em repouso pela infraestrutura do Google Cloud, onde o Firebase roda, com servidores na região das Américas.

4. Escalabilidade

P: O aplicativo aguenta crescer?

R: A base de dados é o Firestore, gerenciado pelo Google e projetado para escalar de forma automática conforme a demanda, sem precisar provisionar servidores. O modelo multi-tenant permite adicionar empresas e famílias sem mexer na arquitetura.

P: Como vocês evitam consultas lentas conforme cresce?

R: Com índices adequados e consultas que trazem só o necessário. As métricas do painel, por exemplo, usam contagem no servidor em vez de baixar todos os documentos, o que mantém o custo e a velocidade estáveis mesmo com muitos pacientes.

P: Qual é o gargalo conhecido hoje?

R: Três, todos mapeados. As fotos ainda ficam no banco em vez do armazenamento dedicado. A trilha de auditoria é gravada pelo aplicativo, não pelo servidor. E cada conta pertence a um único tenant, então um enfermeiro que atenda várias famílias diferentes ainda não cabe num acesso só. Nenhum é bloqueante agora, e cada um tem caminho de evolução.

Dica: Mostrar que você conhece os próprios gargalos vale mais do que dizer que não há nenhum.

P: E quando precisar de notificações e lógica no servidor?

R: O caminho é ativar as funções na nuvem (Cloud Functions), que exige o plano pago do Firebase. Está previsto, e o código já está preparado para essa migração. Ficou para quando houver receita que justifique o custo.

5. Manutenção e operação

P: Quem mantém o aplicativo?

R: O desenvolvimento é conduzido pelo Iago. O código é organizado, tipado e documentado, com regras de projeto registradas, o que reduz a dependência de uma pessoa só e facilita trazer mais gente quando for a hora.

P: Como garantem qualidade a cada mudança?

R: Toda alteração passa por um portão obrigatório de checagem de tipos e análise de código antes de ser concluída. Há regras de projeto documentadas que impedem repetir erros conhecidos, e atualização automática de dependências para segurança.

P: Como corrigem um problema em produção?

R: As regras de segurança e os índices são publicados de forma independente do aplicativo, então um ajuste de segurança sobe em minutos, sem precisar de nova versão nas lojas. Correções de tela sobem na próxima atualização do aplicativo.

P: Quanto custa manter?

R: No estágio atual, o custo de infraestrutura é baixo e proporcional ao uso (banco, autenticação e hospedagem do Firebase). Ele cresce junto com o número de usuários, de forma previsível, e só passa para o plano pago quando funções no servidor forem necessárias.

P: Como é feito backup e migração de dados?

R: O Firestore permite exportação dos dados, e há scripts de manutenção versionados para tarefas como popular dados de teste, corrigir campos em massa e preparar ambientes. Tudo documentado.

6. Modelo de negócio e mercado

P: Como o aplicativo ganha dinheiro?

R: Cobrança mensal calculada pelos pacientes ativos. No modo empresa, a clínica paga e pode repassar o custo para a família ou absorver como diferencial. No modo família, há espaço para cobrar por acessos extras (por exemplo, mais de um parente acompanhando).

P: Quem é o cliente que paga?

R: Principalmente a empresa de cuidado domiciliar, que é a controladora dos dados e a compradora. O modo família abre um segundo caminho, direto com quem cuida em casa.

P: Qual o diferencial em relação a um grupo de WhatsApp ou papel?

R: Histórico confiável e organizado, transparência em tempo real para a família, controle de quem acessa o quê, e trilha de auditoria que protege enfermeiro, família e empresa em caso de dúvida. Nada disso o WhatsApp entrega.

P: Como pretende crescer?

R: Fechar as primeiras empresas clientes, usar o modo família como porta de entrada de baixo atrito, e evoluir a monetização por acesso extra conforme a base cresce.

Dica: Se tiver número real de clientes ou conversas em andamento, cite aqui. Se não tiver ainda, seja honesto: está em validação.

7. Perguntas difíceis (objeções)

P: É só um aplicativo, o que impede uma empresa grande de copiar?

R: A tecnologia é replicável, mas o valor está na execução: entender o fluxo real do cuidado domiciliar, a confiança das empresas e famílias, e o cuidado com segurança e LGPD que já está embutido. Copiar a tela é fácil, copiar a operação e a confiança não.

P: Vocês dependem do Firebase. E se o Google mudar preço ou descontinuar?

R: O risco existe em qualquer fornecedor de nuvem. A mitigação é que a lógica de negócio está no aplicativo, não amarrada a recursos exclusivos, e os dados são exportáveis, o que mantém a porta aberta para migrar se algum dia fizer sentido. No estágio atual, o custo-benefício do Firebase é muito favorável.

P: É um desenvolvedor só. E se você sair ou ficar indisponível?

R: É um risco real de qualquer projeto em estágio inicial. A mitigação é código organizado, tipado e documentado, com as decisões e regras registradas, o que encurta muito o tempo de outra pessoa assumir. Crescer o time é parte natural do próximo passo.

P: Dados de saúde são sensíveis. Qual o plano se houver um incidente?

R: A LGPD prevê comunicar a controladora e apoiar a resposta à ANPD, e isso está no contrato. Tecnicamente, o isolamento por empresa e por enfermeiro limita o alcance de qualquer exposição, e a trilha de auditoria ajuda a entender o que aconteceu.

P: Um enfermeiro consegue burlar o isolamento e ver pacientes de outros?

R: Não pela tela nem por chamada direta ao banco: a decisão de acesso é da regra do servidor, que exige o enfermeiro na lista de autorizados do paciente. Uma consulta mais ampla do que o permitido é recusada inteira, não filtrada.

P: Já tem cliente pagante?

R: Responda com a verdade do seu momento. Se já tem, cite. Se está em validação ou conversas iniciais, diga isso com clareza e mostre o que já está pronto: o produto funcionando, testado e no ar.

Dica: Nunca invente tração. Investidor experiente percebe, e honestidade sobre o estágio conta a seu favor.